SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO UF0127



U.F. 0127:

Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes.

MÓDULO FORMATIVO 1: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL (MF1016_ 2; 100 horas)

Asociado a la UC 1016, preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar.



Francisca Ros Nicolás
Imagen obtenida desde artelista.com

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Identificar el modelo organizativo tipo y de funcionamiento de las instituciones de atención social dirigidas a colectivos de intervención.

CE1.1 Describir los requisitos y características organizativas y funcionales que deben reunir las instituciones residenciales dirigidas a personas dependientes.

CE1.2 Identificar la composición del equipo interdisciplinar de una Institución residencial concretando las funciones de cada uno de sus miembros y procedimientos de coordinación.

CE1.3 Enumerar y describir las funciones de su papel profesional en una institución como miembro de un equipo interdisciplinar citando el procedimiento de transmisión de información y colaboración en el mismo.

CE1.4 Explicar la forma de apoyar a otros profesionales en el acompañamiento al nuevo usuario a la llegada a una institución siguiendo un protocolo de recepción.

C2: Definir el proceso de desarrollo de intervenciones dirigidas a cubrir actividades de la vida diaria de las personas, potenciando la mejora y/o el mantenimiento de la autonomía.

CE2.1 Identificar los niveles de autonomía de personas dependientes relacionándolos con la cobertura de necesidades atención básica, que permitan adaptarse a protocolos de actuación.

CE2.2 Explicar diferentes procedimientos que fomenten la participación de las personas usuarias.

CE2.3 Reconocer y valorar la forma de acompañamiento en las actividades de la vida diaria.

CE2.4 En un supuesto práctico de intervención en una institución de personas dependientes, que tiene como referente el programa establecido por el profesional competente, definir actuaciones para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.

C3: Establecer la forma de participación en la organización de actividades sociosanitarias en una institución social explicando la colaboración en el equipo interdisciplinar.

CE3.1 Describir la participación en la realización de actividades sociosanitarias en instituciones sociales indicando las funciones a desarrollar durante las mismas.

CE3.2 Explicar la forma de transmitir información a las personas usuarias sobre el desarrollo de las actividades sociosanitarias.

CE3.3 En un supuesto práctico de simulación de desarrollo de actividades sociosanitarias en una institución social:

- Informar a las personas usuarias sobre el desarrollo de las actividades previstas facilitando la participación de las personas usuarias.
- Considerar las características e intereses de las personas usuarias en la realización de las actividades.
- Observar y comunicar al equipo interdisciplinar las incidencias en el orden y estado de los materiales.

CE3.4 Comparar diferentes inventarios de mobiliario tipo y materiales correspondientes a instituciones de atención a personas, analizando sus características, condiciones de uso y utilidad.

CE3.5 En un supuesto práctico de organización espacial de una pequeña institución, debidamente caracterizado:

- Identificar las necesidades específicas de acondicionamiento del entorno: de movilidad, de desplazamiento, de uso y utilidad.
- Diseñar la distribución espacial adecuada a la situación.
- Identificar las ayudas técnicas que requiera aplicar y las verificaciones para garantizar su correcto funcionamiento.
- Confeccionar el listado de mobiliario e instrumentos de trabajo.
- Programar y temporalizar las intervenciones.

CE3.6 A partir de documentación sobre planes de cuidados individualizados:

1. Definir sus elementos constitutivos.
2. Describir las características y necesidades presentadas por la persona usuaria en cada caso.
3. Deducir la información que se necesita recopilar para su elaboración.
4. Asociar las intervenciones planificadas a las necesidades y características de la persona usuaria.
5. Identificar los criterios y las estrategias establecidos.

Al margen de la consecución de los contenidos de este módulo formativo hay capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo y son:

- C2 respecto a CE2.4;
- C3 respecto a CE3.3.
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
- Participar y colaborar activamente ene el equipo, habituándose al ritmo de trabajo.
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización.
- Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico profesionales.
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

UNIDAD FORMATIVA 1: APOYO EN LA RECEPCIÓN Y ACOGIDA EN INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES (UF0127; 30 horas)

Objetivos:

- Identificar el modelo organizativo tipo y funcionamiento de instituciones de atención social dirigidas a colectivos de intervención
- Describir los requisitos y las características organizativas y funcionales que deben reunir las instituciones residenciales dirigidas a personas dependientes
- Identificar la composición del equipo interdisciplinar de una institución residencial concretando las funciones de cada uno de sus miembros y procedimientos de coordinación.
- Enumerar y describir las funciones de su papel profesional en un institución como miembro de un equipo interdisciplinar.

Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad en las diversas tareas.

Según el Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos certificados de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el repertorio Nacional de Certificados Profesionalidad, establece que el profesional de atención sociosanitaria tiene la competencia general (lo que debe realizar en su actividad diaria) “atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno”

Contenidos:

1. Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno

En la sociedad actual los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia.

Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, añadiendo el fenómeno demográfico denominado «envejecimiento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años. Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez más amplio. Es evidente la correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad.

A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.

Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se entiende por:

- *Autonomía*: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
- *Dependencia*: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
- *Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)*: las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
- *Necesidades de apoyo para la autonomía personal*: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.
- *Cuidados no profesionales:* la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.
- *Cuidados profesionales*: los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.
- *Asistencia personal*: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal.
- *Tercer sector*: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

1.1.- Instituciones, programas y profesionales de atención directa a personas dependientes: características.

Instituciones

Tomando como referente nuevamente la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención se contemplan, el Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia son:

NO INSTITUCIONALES:

- Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal.

Tienen por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos.

- Servicio de Teleasistencia.

El servicio de Teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.

En la CCAA del País Vasco la Teleasistencia está regulada por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y se gestiona hasta el momento por las Diputaciones Forales hasta culminar traspaso de gestión al Gobierno Vasco.

En el siguiente enlace podéis ampliar información del servicio:

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-contss/es/contenidos/informacion/teleasistencia/es_teleasis/teleasistencia.html

INSTITUCIONALES

- Servicio de Ayuda a domicilio:

Este servicio puede ser tratado como una institución, en el caso de tratarse de un piso tutelado o también puede estar incluido, situación mas usual, dentro de la atención domiciliaria.

El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función.

Son servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros y con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria.

En este capítulo se incluyen los pisos tutelados además de los propios hogares de las personas dependientes (viviendo solos o integrados en una unidad familiar).

- Servicio de Centro de Día y de Noche:

El servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención integral durante el periodo de incontinencia diario o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.

La tipología de centros incluirá:

  - Centros de Día para menores de 65 años
  - Centros de Día para mayores,
  - Centros de Día de atención especializada por la especificidad de los cuidados que ofrecen
  - Centros de Noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia.

- Servicio de Atención Residencial:

El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.

Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.

La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales.

El servicio de atención residencial será prestado por las Administraciones Públicas en centros propios y concertados.

Dentro de la asistencia residencial está suele ser:

- Residencia de personas mayores en situación de dependencia. Reguladas en la CCAA del País Vasco por el DECRETO 41/1998, de 10 de marzo, sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad. A los efectos del presente Decreto los servicios sociales residenciales para la tercera edad se clasifican en:
  - Apartamentos tutelados: Conjunto de viviendas autónomas, unipersonales y/o de pareja, que cuentan con servicios colectivos, de uso facultativo, y que dan alojamiento a personas mayores con una situación psíco-fisica y social que no precisa de recursos de mayor intensidad.
  - Vivienda comunitaria: Unidad convivencial con un máximo de 14 plazas, destinada a personas mayores que posean un cierto nivel de autovalimiento, y con un estilo de vida similar al del ambiente familiar.
  - Residencia: Centro de convivencia con capacidad superior a 14 plazas, destinado a servir de vivienda permanente y común, en el que se presta una atención integral y continua a las personas mayores. Estará dotada necesariamente de los medios materiales suficientes para la atención de discapacidades de alto grado.
- Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad (daño cerebral, daño medular...)

Programas de atención directa a personas dependientes

Según indica el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, los centros residenciales deberán contar con:

- Reuniones periódicas de personal: preferiblemente tendrán carácter semanal y obligatoriamente, como mínimo, una periodicidad mensual.
- En la atención a las personas residentes el personal tendrá a su disposición un manual de buena práctica, propio o asimilado.
- Programas de atención directa individualizada con asignación a cada residente de un/una trabajador/a clave o de referencia.
- Protocolos de actuación del personal.
- En cuanto al personal, en materia de seguridad e higiene, se cumplirán los requisitos específicos contenidos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Se establecerá un programa anual de actividades, organizadas y diversas, con indicación de los objetivos, calendario, métodos y técnicas de ejecución, y sistemas de evaluación.

- Con carácter específico e idénticas indicaciones, existirá un programa de animación socio-cultural y, en su caso, un programa de prevención y tratamiento para las personas con confusión mental.
- Elaboración y puesta en funcionamiento de un programa de actividades específico de participación en la comunidad y entorno social donde esté ubicada la residencia, fomentando así la integración de las personas usuarias con los demás sectores de población y la relación con otros recursos comunitarios.
- Implantación de un proceso dinámico e integrador en que se conciba la residencia como espacio abierto, donde se realizan actividades en las que puedan participar el resto de colectivos de la comunidad.
- Programa de formación permanente para el personal

Los programas de intervención concretarán los objetivos generales y específicos perseguidos en cada centro en una serie de objetivos operativos, servicios y planes de actuación, materializados en actividades individualizadas para cada persona.

En la siguiente tabla se recogen algunos de los programas más habituales y los profesionales asociados a los mismos que se manejan en los centros residenciales organizados por áreas de intervención:

Profesionales de atención directa a personas dependientes

No trabajamos de forma aislada, sino en un equipo. Cada profesional colabora desde su disciplina con otros profesionales, programando y organizando, planes conjuntos con el objetivo de mejorar la autonomía de las personas usuarias. Por eso se dice que es un equipo interdisciplinar.

Para que un equipo interdisciplinar sea un auténtico equipo eficaz en su funcionamiento y no sólo una suma de profesionales, debe reunir las siguientes características:

- Los objetivos son comunes
- están integrados por un grupo de personas con formación diversa
- Hay interacción entre sus componentes en un espacio compartido.
- La responsabilidad y la toma de decisiones es conjunta.
- El trabajo de cada miembro del equipo depende del de los demás
- No todos los centros cuentan con el mismo equipo de profesionales, este se adecua a las necesidades de cada centro.

La institución social cuenta con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de diversas disciplinas se engloban en las siguientes áreas de intervención:

- Área sociosanitaria: médicos (generales y especialistas como rehabilitación, etc.), farmacéuticos, psicólogos, sociólogos, personal de enfermería (DUE y auxiliares), trabajadores sociales, fisioterapeutas,

terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales, gerocultores y cuidadores en atención directa.

- Profesionales de servicios generales: personal de cocina, de limpieza, de lavandería, conductores, personal de mantenimiento, jardineros, encargado de servicios, portero, etc.
- Personal de gestión y administración: recepcionista, oficial y auxiliar administrativo, gobernanta, contable-administrador, responsable de recursos humanos, relaciones públicas y atención al cliente, coordinadores de área, gerente y director, entre otros.
- Otros profesionales que prestarán servicios integrados como trabajadores del centro o ejerciendo como profesionales autónomos colaboradores en cafetería, peluquería, podología, etc.

1.2.- Papel de los diferentes profesionales de atención sociosanitaria. El equipo interdisciplinar.

La gran variedad de causas y efectos relacionados que existen en el trabajo con las personas en situación de dependencia, requiere realizar esta labor desde un punto de vista de interconexión entre varias disciplinas. El trabajo interdisciplinar se basará, por tanto, en la globalidad; es decir, en valorar a la persona desde todos los aspectos de su vida, ya que sus necesidades y demandas son múltiples, diversas y relacionadas internamente entre sí. De hecho, estas personas pueden presentar situaciones en las que estén implicados factores sociales, económicos, físicos, psíquicos y emocionales, lo que hace necesario que los distintos profesionales que intervienen en su atención deban colaborar de forma conjunta y coordinada. De este modo, cada uno de ellos aporta su rol y sus conocimientos, adoptando una posición flexible que se nutrirá de una perspectiva distinta, ampliando y transformando su comprensión de la situación y de las estrategias de intervención. Por ello, se trata de que el diagnóstico y el plan de trabajo se elaboren conjuntamente en equipo y la distribución de las tareas la determine la capacidad y competencia de cada uno de sus componentes.

La RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal[1], que se recogen en esta resolución las principales funciones de los profesionales de la atención sociosanitaria en instituciones serían:

MÉDICO-MÉDICO ESPECIALISTA (Geriatra, Rehabilitador, etc.)

- Realizar el reconocimiento médico a los nuevos usuarios y cumplimentar la correspondiente historia médica y certificaciones profesionales, en que

1 Queda excluido de esta resolución el personal de las instituciones públicas, pero las funciones que desempeñan vienen a ser las mismas.

constarán las indicaciones de tipo de vida más acorde, la rehabilitación necesaria, y el tratamiento a seguir si hace falta.

- Atender las necesidades asistenciales de las personas usuarias. Hacer los exámenes médicos, diagnósticos, prescribir los tratamientos más acordes, en cada caso, para llevar a cabo las terapias preventivas, asistenciales y de rehabilitación de los diagnósticos clínicos y funcionales de las personas usuarias.
- Informar a los familiares sobre el estado de salud de la persona usuaria.
- Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de las personas usuarias, fijando en equipo los programas a desarrollar de forma individual y en grupo. Realizar el seguimiento y evaluar los programas, conjuntamente, con el equipo formado por todas las personas que intervienen.
- Asistir al personal destinado en el centro en los casos de necesidad y de urgencia.
- Como máximo responsable de su departamento médico, en el caso de que el centro no pueda tratar debidamente a las personas usuarias, derivarlos a un centro hospitalario o de salud.
- Participar en la comisión de supervisión y seguimiento de las personas usuarias en cuanto a las necesidades asistenciales y de la vida diaria de las personas usuarias que realizarán en colaboración con el director, el trabajador social, el psicólogo, y otros profesionales, de acuerdo con la situación física de las personas usuarias, los objetivos a conseguir y las características del centro.
- Programar y supervisar los menús y dietas alimentarías de las personas usuarias.
- Supervisar el trabajo del personal sanitario.
- Supervisar el estado sanitario de las dependencias del centro.
- En general, todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan, de acuerdo con su titulación y profesión.

OTROS TITULADOS SUPERIORES se les exigen todas aquellas actividades que se le pidan de acuerdo con su titulación y profesión.

ENFERMERA (DUE):

- Vigilar y atender a las personas usuarias, sus necesidades generales humanas y sanitarias, especialmente en el momento en que éstos necesiten de sus servicios.
- Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas, específicamente los tratamientos.
- Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.
- Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que hayan de ser utilizados.
- Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función que deba figurar.

- Atender al usuario encamado por enfermedad, efectuando los cambios posturales prescritos, controlando el servicio de comidas a los enfermos y suministrando directamente a aquellos persona usuarias que dicha alimentación requiera instrumentalización (sonda nasogástrica, sonda gástrica, etc.).
- Controlar la higiene personal de las personas usuarias y también los medicamentos y alimentos que estos tengan en las habitaciones.
- Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaja en el centro y sean de su competencia.
- Colaborar con los/as fisioterapeutas en las actividades, el nivel de calificación de las cuales sean compatibles con su titulación de ATS/DUE, cuando sus funciones específicas lo permitan.
- Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología en aquellos centros donde no exista especialista.
- Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico recibida por el médico, observando las incidencias que puedan presentarse durante su realización.
- En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo anterior

TRABAJADOR SOCIAL:

- Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante una adecuada programación de objetivos y racionalización del trabajo.
- Colaborar y realizar aquellos estudios encaminados a investigar los aspectos sociales relativos a las personas usuarias.
- Ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes sociales de las personas usuarias y los que le sean pedidos por la dirección del centro, facilitar información sobre los recursos propios, ajenos y efectuar la valoración de su situación personal, familiar y social.
- Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio social de cada caso y de grupo a todos las personas usuarias.
- Fomentar la integración y participación de las personas usuarias en la vida del centro y de su entorno.
- Participar en la preparación y puesta en marcha de programas de adaptación de las personas usuarias al centro.
- Coordinar los grupos de trabajo y actividades de animación sociocultural.
- Participar en la comisión técnica.
- Realizar las gestiones necesarias para la resolución de problemas sociales que afecten a las personas usuarias principalmente con las entidades e instituciones locales.
- Participar, con el equipo multiprofesional o departamento médico en la elaboración de las orientaciones o de la atención que necesiten las personas usuarias.
- Participar en la asignación y cambio de habitaciones y mesas del comedor con el departamento de enfermería y la dirección.

- Visitar a las personas usuarias enfermos.
- En general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo anterior.

FISIOTERAPEUTA:

- Realizar los tratamientos y técnica rehabilitadora que se prescriban.
- Participar, cuando se le pida, en el equipo multiprofesional del centro para la realización de pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional.
- Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación de tratamiento que realice.
- Conocer, evaluar e informar y cambiar, en su caso, la aplicación del tratamiento de su especialidad, cuando se den, mediante la utilización de recursos ajenos.
- Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorial.
- Participar en juntas y sesiones de trabajos que se convoquen en el centro.
- Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e información a las familias de las personas usuarias e instituciones.
- Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas.
- Asistir a las sesiones que se hagan en los centros para la revisión, el seguimiento y la evaluación de tratamientos.
- En general en todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo anterior.

GOBERNANTE:

- Organizar, distribuir y coordinar los servicios de comedor u office, lavandería, lencería y limpieza.
- Supervisar la actividad de los trabajadores a su cargo, distribuir las actividades y turnos de las personas que tiene asignadas y vigilar también el buen uso y economía de los materiales, utillaje y herramientas y maquinaria a su cargo; proceder al recuento e inventario de éstos.
- En coordinación con el departamento de cocina, se responsabilizará de la buena marcha del servicio de comedor, distribución de comidas, control de regímenes, servicios especiales, montaje, limpieza y retirada del servicio.
- Tener conocimiento del número de servicios diarios realizados en el departamento.
- En coordinación con el personal de enfermería y contando con el personal que tiene adscrito, llevar el control del buen estado de los alimentos que las personas usuarias tengan en las habitaciones.

- En los centros, cuyas comidas se realicen mediante conciertos con terceros, colaborar en la confección de los menús, supervisar las condiciones sanitarias de las dependencias y alimentos servidos.
- Vigilará el cumplimiento de la labor profesional del personal a su cargo, así como de su higiene y uniformidad.
- Supervisar, cuando haya contrato de limpieza, el buen funcionamiento de los servicios contratados.
- Si por necesidades perentorias o imprevisibles, la normal actividad del centro lo requiere, colaborar en las actividades propias del personal a sus órdenes.

TERAPEUTA OCUPACIONAL:

- Participar en el plan general de actividades del centro.
- Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, lenguaje, dinámicas y rehabilitación personal y social a las personas usuarias.
- Colaborar en el seguimiento o la evaluación del proceso recuperador o asistencial de las personas usuarias del centro.
- Participar en las áreas de ocio y tiempos libres de las personas usuarias del centro.
- Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e información a las familias de las personas usuarias a las instituciones.

TÉCNICO EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES (TASOC):

- Conocer, proponer y hacer operativos los procesos de intervención cultural en sus vertientes de gestión y educativa.
- Establecer relaciones entre los ámbitos cultural y educativo con los procesos sociales y económicos.
- Acceder a las fuentes de información y procedimientos para obtener recursos necesarios y poner en marcha procesos culturales.
- Coordinación con profesionales de diversa cualificación a la hora de diseñar e implementar estrategias de intervención cultural.
- Ejecución y presupuestación de proyectos y programas varios, así como realización de los informes y evaluaciones pertinentes.
- Realización de programas y proyectos específicos.
- Fomentar el desarrollo integral de las personas usuarias mediante la acción lúdico-educativa.
- Desarrollar y ejecutar las diversas técnicas de animación, individuales y/o grupales, que impliquen a las personas usuarias en la ocupación de su tiempo libre y promover así su integración y desarrollo grupal.
- Motivar a las personas usuarias ante la importancia de su participación para conseguir su integración y relación positiva con el entorno.
- Responsabilidad ante cualquier incidencia que surja, en cualquier tipo de labor propia o de los animadores socioculturales.

- Reuniones periódicas con el resto del equipo, así como con los responsables de los diferentes centros donde se realice la labor de animación sociocultural.
- Coordinación del voluntariado y alumnos en prácticas de animación sociocultural.
- Docencia, charlas y ponencias que guarden relación con esta categoría profesional.
- Participar en el plan general de actividades y presupuestos de los diferentes centros.
- Coordinar los grupos de trabajo, actividades y presupuestos de animación sociocultural.
- Comunicar a su inmediato las incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de sus funciones.

OFICIAL DE MANTENIMIENTO:

- Es el responsable directo de la explotación y mantenimiento de todas las instalaciones del centro; programa el trabajo a realizar, él realiza directamente y ordena su ejecución a los auxiliares y ayudantes de servicios técnicos.
- Controlar las visitas y el trabajo realizado por las firmas contratadas para el mantenimiento de aquellas instalaciones donde esté establecido.
- Realizar las operaciones reglamentarias definidas en los reglamentos de las instalaciones o en las instrucciones técnicas que las desarrollan, y que los valores correspondientes de los diferentes parámetros se mantengan dentro de los límites exigidos a éstos.
- Elaborar planes de mantenimiento de aquellos oficios que específicamente no se definen legalmente.
- Guardar y custodiar los libros de mantenimiento, manual de instrucciones, libro de visitas establecidas en la legislación vigente o los que en un futuro puedan establecerse.
- Anotar las operaciones que se realicen en las instalaciones y revisar las que ejecute personal de firmas ajenas al centro.
- Tener cuidado de la sala de máquinas, instalaciones, cuadros eléctricos, transformadores, taller y aquellos materiales que no le sean propios.
- Tener control del montaje, funcionamiento y desmontaje de estrados, escenarios, asientos, proyector de cine, altavoces, etc. que sean necesarios para el normal desenvolvimiento de actividades del centro.
- Realizar todas las funciones que tengan señaladas los oficiales de los servicios técnicos, y como encargado de este departamento, responsabilizarse directamente de los trabajos efectuados y de su distribución, de la realización y cumplimiento de las órdenes que le dé la empresa, de recibir los partes de averías de los respectivos jefes de sección.
- Tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla con regularidad su actividad profesional y comunicar a la dirección las faltas que vea.

- En el ejercicio de su cargo, dar las máximas facilidades para la obtención de una perfecta formación profesional.

OFICIAL ADMINISTRATIVO:

- Es el trabajador, que actúa a las órdenes de los directivos del centro y tiene a su cargo un servicio determinado dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin otros trabajadores a sus órdenes, realiza trabajos que exijan cálculos, estudios, preparación y condiciones adecuadas, tales como cálculos de estadística, transcripciones de libros de cuentas corrientes, redacción de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculos de nóminas de salarios, sueldos y operaciones análogas, de forma manual o mecanizada.
- Se consideran incluidos en esta categoría los cajeros de cobros y pagos sin firma, que perciben plus de quebranto de moneda.
- En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo anterior.

CONDUCTOR:

- Deberán realizar los trabajos propios de su especialidad en relación con los vehículos automóviles al servicio de los centros y deberán ejecutar las reparaciones que no requieran elementos de taller.

GEROCULTOR:

- Higiene personal de las personas usuarias.
- Efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensilios de las personas usuarias, hacer las camas, colaborar en mantener ordenadas las habitaciones, recoger la ropa, llevarla a la lavandería y encargarse de la ropa personal de las personas usuarias.
- Dar de comer a aquellas personas usuarias que no lo puedan hacer por si mismos. En este sentido, se ocupará igualmente de la recepción, distribución y recogida de las comidas a las personas usuarias.
- Realizar los cambios de postura y aquellos servicios auxiliares que de acuerdo con su preparación técnica le sean encomendados.
- Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de las personas usuarias.
- Limpiar y preparar el mobiliario, materiales y aparatos de botiquín.
- Acompañar a las personas usuarias en las salidas que este deba realizar ya sean para citas médicas, excursiones, gestiones, etc.

- Colaborar con el equipo de profesionales mediante la realización de tareas elementales que complementen los servicios especializados de aquellos, en orden a proporcionar la autonomía personal de las personas usuarias y su inserción en la vida social.
- Atender, siempre dentro de las pautas que marquen la dirección y el plan funcional, a los familiares de las personas usuarias y colaborar a la integración de éstos en la vida del centro.
- En todas las relaciones o actividades con las personas usuarias, procurar complementar el trabajo asistencial, educativo y formativo que reciban de los profesionales respectivos.
- En general, todas aquellas actividades que no habiéndose especificado antes le sean encomendadas y siempre que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación técnica.

COCINERO:

- Como responsable del departamento, se ocupará de la organización, distribución y coordinación de todo el personal adscrito a la cocina así como de la elaboración y condimentación de las comidas, con sujeción al menú y regímenes alimentarios que propondrá para su aprobación a la dirección del centro y supervisión del departamento médico.
- Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extraordinarios que diariamente se comuniquen.
- Disponer entre el personal de cocina, el montaje de los carros con los menús elaborados.
- Vigilar el almacenamiento y control de los alimentos, mirando de suministrar los artículos de ésta al almacén, vigilando su estado, que se encargará de sacar, a medida que se necesite para su confección de los diferentes servicios a realizar.
- Recontar las existencias con los administradores de los centros, comunicar a la dirección las faltas que vea y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla con su actividad profesional, vigilar también su higiene y su uniformidad.
- Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento de la maquinaria y utensilios propios del departamento tales como: bandejas, hornos, freidora, extractores, filtros, cortadoras, ollas, etc.
- Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar, estén en consonancia con su lugar de trabajo y cualificación profesional.

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO:

- Es el operario que realiza, directamente o con la ayuda de los ayudantes, las operaciones de explotación y mantenimiento del centro, sus instalaciones y exteriores; hace el montaje, el ajuste, y la puesta a punto de todo tipo de instalaciones de medida, regulación y control simple o

automático de temperatura, previsiones de caudales, de poder calorífico, de niveles analizadores de agua y similares, etc. Así mismo realizará las siguientes funciones:

- Trabajos de albañilería, pintura, carpintería, etc. que es necesario para el mantenimiento de las instalaciones o del edificio.
- Comprobaciones periódicas en las máquinas o instalaciones marcadas en los reglamentos e instrucciones técnicas de éstos, hace que los valores definitivos en aquellos se encuentren dentro de los límites permitidos.
- Limpieza de las salas de máquinas, instalaciones, cuadros eléctricos, transformadores, taller etc.
- Montaje de tarimas, estrados, escenarios, asientos, la puesta en funcionamiento de altavoces, equipos de música, proyección, etc., para el normal desarrollo de las actividades del centro.
- Pequeñas operaciones en los dispositivos de las instalaciones mencionadas y en los aparatos portátiles considerados como utillaje.
- Rellenar los comunicados de trabajo y fichas de revisión o verificación de cada instrumento reparado para la correcta marcha del servicio.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

- Es el trabajador que, con iniciativa y responsabilidad restringida y subordinada a los órganos directivos del centro realiza funciones de mecanografía, archivo y otras actividades de técnicas administrativas.
- En general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo anterior.

RECEPCIONISTA:

- Es el trabajador cuyas funciones consisten en la recogida y libramiento de correspondencia, orientación al público, atención de centralitas telefónicas, vigilancia de los puntos de acceso y tareas de portería.
- Colabora excepcionalmente con el personal en aquellas tareas que, por su exceso de peso no pueda realizar este personal solo.
- Cumplimenta los partes de entrada y salida de las personas usuarias cuando estas se produzcan por permisos o vacaciones.
- Archivará las peticiones de salida o retraso en la llegada de las personas usuarias, según se contempla en el reglamento de régimen interior del centro
- Ayuda a aquellas personas usuarias que lo necesiten en el traslado del equipaje hasta y desde las habitaciones, ejerciendo un obligado y discreto control de los paquetes que traigan al centro las personas que tengan acceso, igualmente el control de entradas y salidas del personal.
- Mantiene el régimen establecido por la dirección para el acceso de usuarios y visitantes a las diferentes dependencias de la institución.
- Se hace cargo de los partes de avería y les da traslado al servicio de mantenimiento.

- Tiene a su cargo el traslado de las personas usuarias, tanto dentro de la institución, como en los servicios de ambulancias, autobuses etc.

LIMPIADOR-PLANCHADOR:

- Realiza su trabajo a las órdenes inmediatas del gobernante o de la dirección.
- Realizar las tareas propias de comedor-office, poniendo un cuidado especial en el uso de los materiales encomendados.
- Realizar las funciones propias de lavandería, lencería, uso y atención de la maquinaria, tener cuidado de la ropa de las personas usuarias y del centro, y dar la mejor utilización a los materiales.
- Realizar las tareas propias de limpieza de las habitaciones y zonas comunes (camas, cambios de ropa, baños, ventanales y balcones, mobiliario etc.) procurando ocasionar las menores molestias a las personas usuarias.
- Comunicar a su jefe inmediato las incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de su tarea (averías, deterioros, desorden manifiesto, alimentos en malas condiciones, etc.).

PINCHE DE COCINA:

- Bajo las órdenes del cocinero realizarán la preparación de los víveres para su condimento, el encendido y mantenimiento del horno y hogares, así como su limpieza y la limpieza de los útiles de cocina y comedor.

AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS:

- Trabaja a las órdenes de otros profesionales; procurará su formación profesional, poniendo todo su celo en las tareas que le sean encomendadas.
- Mantener en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento la maquinaria y los utensilios del centro.

PERSONAL NO CUALIFICADO:

- Se encargará de la realización de las tareas elementales, propias de su nivel que no requiera una especial cualificación.

1.3.- Tareas del profesional de atención sociosanitaria. Competencia y responsabilidad

El profesional de atención sociosanitaria en su actividad diaria debe atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar

competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

Sus funciones serán las de ejecutar y desarrollar las intervenciones programadas por los diversos profesionales del equipo interdisciplinar en las siguientes áreas:

ÁREA DE ALIMENTACIÓN

- Colaborar en la realización del servicio de comidas en comedor y en habitaciones, que corresponda a la dieta personalizada de la persona.
- Colaborar en la detección e informar al profesional responsable de problemas de alimentación.
- Informar y ayudar al usuario para llevar a cabo las comidas.
- Colaborar en las tareas para alimentar a la persona con disfagia (es decir, con problemas para tragar).
- Colaborar en la alimentación a la persona con sonda nasogástrica.
- Colaborar en el control de los alimentos ingeridos.
- Colaborar en el control de la ingesta de líquidos.
- Colaborar en la administración de hidratación oral y gelatinas.
- Actuar en caso de vómitos.
- Actuar en caso de atragantamiento.

ÁREA DE HIGIENE Y ASEO

- Colaborar en la realización de la higiene total en estado encamado y no encamado (del cabello, de genitales y zona anal, de boca, de zonas específicas como uñas, oreja, etc.), en estado consciente o inconsciente.
- Colaborar en la valoración de la higiene diaria en estado no encamado.
- Afeitar y depilar.
- Colaborar en los cuidados y la prevención del pie diabético.
- Colaborar en el control y mantenimiento del buen estado o integridad cutánea e higiene de heridas.
- Colaborar en la promoción de la continencia; es decir, el control de la micción y de la defecación.
- Ayudar a prevenir la incontinencia o falta de control.
- Colaborar en el desarrollo de los cuidados para prevenir y tratar problemas secundarios a la incontinencia.
- Cuidar a la persona con pañales y/o cuña.
- Colaborar en el apoyo y vigilancia del cateterismo vesical, o tubo introducido por la vía urinaria y que termina en una bolsa o colector, tanto en hombres como en mujeres.
- Colaborar en el mantenimiento y los cuidados del catéter o sondaje vesical.
- Colaborar en el cuidado de las ostomías o estomas.
- Colaborar en el cambio de la bolsa de dincontinencia urinariaresis (para recogida de orina).
- Colaborar en la recogida de muestras de orina sin sondaje y con sondaje.

- Colaborar en la recogida de muestras fecales.
- Colaborar en la administración de enemas

ÁREA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Preparar la habitación para acoger un nuevo ingreso o tras un alta hospitalaria.
- Preparar las pertenencias y útiles de la persona usuaria para el alta o el ingreso hospitalario.
- Cuidar del buen uso de las pertenencias de la persona y del entorno
    - Distribuir la ropa y objetos personales en la habitación.
    - Realizar el mantenimiento y ordenar las dependencias del residente.
    - Cuidar de sus pertenencias.

- Colaborar en la limpieza y preparación del mobiliario, materiales y aparatos de botiquín y tener conocimiento y aplicar las medidas universales de higiene y autoprotección, consistentes en:
    - Lavado de manos higiénico.
    - Desinfección y esterilización del material.
    - Manejo de objetos punzantes y residuos sanitarios.

ÁREA DE ATENCIÓN SANITARIA

- Colaborar en la medición de la frecuencia respiratoria y cardíaca.
- Observar y actuar ante la alteración respiratoria por disnea (sensación de malestar respiratorio, de fatiga o de ventilación anormal) y tos/expectoración.
- Apoyar en fisioterapia respiratoria, oxigenoterapia y mantenimiento de utillaje específico.
- Tomar la temperatura axilar.
- Ante lesiones por presión-úlceras:
    - Colaborar en la identificación y prevención en la persona de riesgo.
    - Colaborar en el desarrollo de cuidados de prevención y de tratamiento.

- Ante caídas: llevar a cabo medidas de prevención y actuación ante una caída.
- Ante infección urinaria: colaborar en el desarrollo de medidas de prevención, detección y tratamiento de la infección urinaria.
- Ante dolor:
    - Identificar a la persona que sufre dolor.
    - Colaborar en la aplicación de medidas de prevención del dolor.
    - Colaborar en la aplicación de métodos no farmacológicos para combatir el dolor: relajación, estimulación cutánea y visualización.

- Ante agitación psicomotriz (aumento significativo de la actividad motora acompañado por alteración emocional como ansiedad severa, miedo, pánico, cólera, euforia, etc.): colaborar en la identificación, prevención y actuación ante la agitación psicomotriz.
- Ante procesos infecciosos:

  - Colaborar en el traslado de información de medidas de precaución a personas usuarias y familiares.
  - Colaborar en la aplicación de medidas de precaución ante el riesgo de difusión y posibles brotes.

- Acompañar al usuario al servicio de urgencias.
- Acompañar para visitas en ambulatorio, por médico especialista o realización de exploraciones complementarias.
- Acompañar para la realización de intervenciones quirúrgicas programadas, con o sin ingreso en el hospital de la persona usuaria.

ÁREA DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN

- Facilitar y apoyar al usuario en el uso de ayudas y soportes para andar (bastones, andadores, muletas, etc.).
- Movilización y traslados con utilización de ayudas mecánicas:
  - Colaborar en la transferencia con grúa.
  - Colaborar en el traslado de la cama a la bañera hidráulica, con transfer (material para movilizar y manejar persona usuarias).
  - Utilizar la camilla tijera (consta de dos palas simétricas y telescópicas que se anclan por sus extremos, cuyo tamaño longitudinal puede regularse al ser telescópicas).

- Movilización y traslados sin utilizar ayudas mecánicas:
  - Colaborar en la transferencia de la cama a la bañera hidráulica (ajustable en altura) sin ayuda mecánica.
  - Colaborar en el traslado del residente de la cama a la silla de ruedas o al sillón.

- Cambios posturales de la persona:
  - Colaborar en la colocación de la persona usuaria en las posiciones de decúbito lateral (posición de costado) y prono (acostado boca abajo).
  - Colaborar en la incorporación de la persona usuaria en la cama a la posición semi-fowler (persona semisentada, su espalda en ángulo de 30º y piernas ligeramente flexionadas).
  - Colaborar en su movilización hacia la cabecera y hacia los lados de la cama.
  - Ayudar a la persona usuaria para ponerse de pie.

ÁREA DE PRIMEROS AUXILIOS

- Aplicar medidas de protección, aviso y socorro (P.A.S.) y realizar valoraciones primarias (reanimación cardio-respiratoria o RCP) y secundarias (lesiones).
- Conocer y aplicar el Plan de Emergencias del Centro.
- Apoyar y ejecutar medidas de prevención, desalojo y evacuación en incidentes.

ÁREA DE APOYO PSICOSOCIAL

- Colaborar en realización de la recepción del residente
- Facilitar la distracción de la persona usuaria, promover su actividad y contribuir a que se sienta útil.
- Apoyar en la motivación y estimulación de la colaboración del residente en las actividades propuestas.
- Facilitar actividades de distracción y ocupación en grupos de usuarios.
- Dar información, identificar y facilitar respuestas ante necesidades de relación sexual, siguiendo indicaciones de los correspondientes profesionales del equipo.
- Colaborar en proporcionar los cuidados establecidos a la persona en situación terminal.
- Colaborar en proporcionar los cuidados indicados a la familia de la persona en situación terminal.
    - Colaborar en la preparación del difunto

ACTIVIDADES DIARIAS.

- Ir con las personas usuarias a todas las actividades que se realicen en el centro tanto asistenciales, sociales, como lúdicas, apoyándoles en su realización y participando en las mismas de manera activa.
- Acompañar y trasladar, cuando sea necesario, a los residentes a las plantas y servicios que les sean asignados (fisioterapia, terapia ocupacional, consulta médica, etc.).
- Realizar todas aquellas actuaciones relacionadas con su titulación y profesionalidad, complementando y facilitando la atención sanitaria en el centro.

COMUNICACIÓN

- Comunicar y animar a los residentes a que participen en las actividades voluntarias y opcionales existentes en el centro.
- Transmitir a los ingresados las actividades obligatorias que deben realizar y acompañarles en las mismas.
- Comunicar con el equipo interdisciplinar aquellas incidencias en el comportamiento, estado de ánimo o evolución del estado de salud de las personas usuarias.

2. Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes:

En este punto nos centraremos en explicar el procedimiento de actuación del profesional en atención sociosanitaria que, siguiendo un protocolo de recepción y acogida, apoya a otros profesionales en el acompañamiento al nuevo usuario a la llegada a la institución social. Únicamente esbozaremos el procedimiento pero si

queréis ampliar información podéis leer la información en la página http://www.infogerontologia.com/pgi/index4.html.

El ingreso en un centro sociosanitario supone un cambio importante en la vida de la persona dependiente. Con frecuencia, la preparación pre-ingreso del residente suele ser escasa o nula y la información sobre la duración de su estancia es, en muchos casos, errónea.

Debemos tener en cuenta que existe un periodo de adaptación que varía en función de la persona, con una duración media de 6 meses desde su ingreso, por lo que, en este periodo, todos los trabajadores de la residencia deben estar implicados en favorecer la adaptación de las personas que son nuevas usuarias.

Concretamente, las tareas de apoyo auxiliar del profesional en atención sociosanitaria a personas dependientes, respecto al protocolo de recepción y acogida de nuevas personas usuarias del centro, deben consistir, al menos, en:

- Preparar la habitación para acoger un ingreso.
- Recibir al residente.
- Distribuir la ropa y objetos personales en la habitación del residente.
- Seguir el proceso de adaptación.

2.1.- Atención a las personas dependientes según su grado de dependencia.

En el apartado 1 de esta UF ya se ha definido el concepto de dependencia pero no se han citado los diferentes grados de dependencia. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia los grados de dependencia son tres:

a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

El Baremo de Valoración de la situación de Dependencia (BVD) evalúa qué capacidad tiene el sujeto para realizar las AVD por sí mismo y si precisa de algún

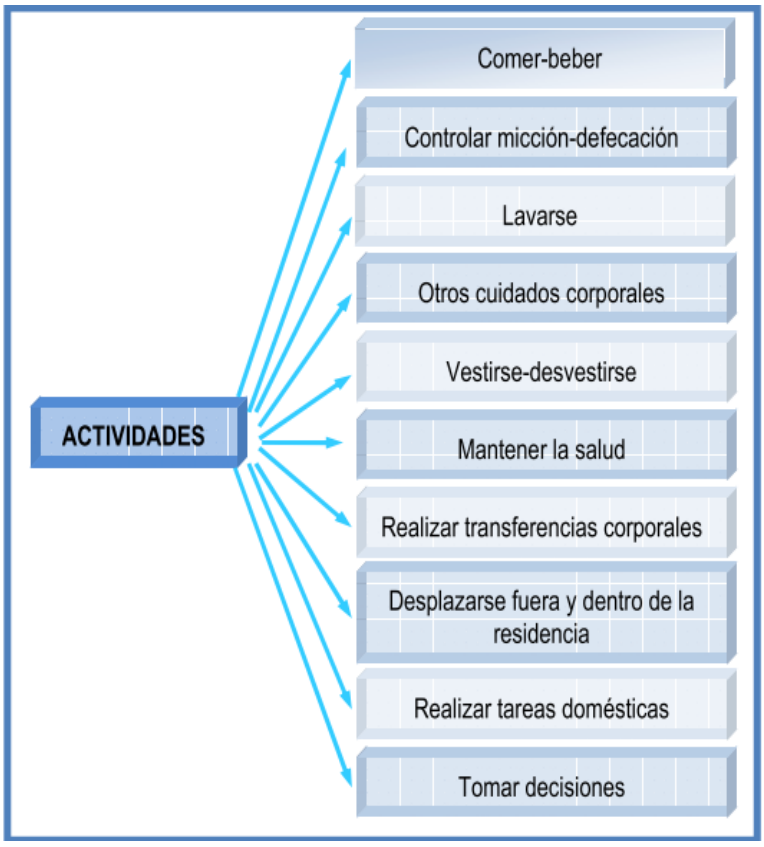
tipo de apoyo o supervisión. En dicha valoración se tienen en cuenta no sólo su estado de salud física sino también el entorno en el que vive, los productos de apoyo que precisa o su estado cognitivo.

Esta valoración consiste en la aplicación de un cuestionario y en la observación por parte del entrevistador (entrenado en el manejo del baremo) del individuo al que se está evaluando. En el caso de personas con demencia, discapacidad intelectual u otra problemática que dificulte la comunicación, la valoración se realizará con ayuda de una tercera persona que conozca bien al sujeto que está siendo valorado.

En función de las puntuaciones obtenidas se clasifica a las personas evaluadas en los diferentes niveles de dependencia.

En la Comunidad Autónoma Vasca, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia está en mano de las diferentes Diputaciones Forales.

En cualquier caso el reconocimiento de la dependencia comienza por la solicitud de la persona interesada o su tutor legal. Los servicios sociales realizan el Baremo de la Valoración de la Dependencia (BVD) teniendo en cuenta:



Junto a esto se valora el nivel de desempeño, los problemas en el desempeño y grado de apoyo requerido para las AVD y las condiciones de salud, funcionamiento, ayudas técnicas y otras observaciones.

La última tabla BVD se recoge en la Resolución de 29 de junio de 2010 publicada en el BOE nº 168 de 12 de julio de 2010 y es la siguiente:

Tabla de aplicación de actividades y tareas

Para todos los casos	Grupos de edad			
	3-6	7-10	11-17	18 y más
Comer y beber	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Reconocer y/o alcanzar los alimentos servidos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cortar o partir la comida en trozos	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Usar cubiertos para llevar la comida a la boca	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Acercarse el recipiente de bebida a la boca	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Higiene personal relacionada con la micción y defecación	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Acudir a un lugar adecuado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Manipular la ropa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Adoptar o abandonar la postura adecuada	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Limpiarse	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Lavarse	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Abrir y cerrar grifos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Lavarse las manos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Acceder a la bañera, ducha o similar.	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Lavarse la parte inferior del cuerpo	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Lavarse la parte superior del cuerpo	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar otros cuidados corporales	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Peinarse	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Cortarse las uñas	NA	NA	SÍ	SÍ
Lavarse el pelo	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Lavarse los dientes	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Vestirse	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Reconocer y alcanzar la ropa y el calzado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Calzarse	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Abrocharse botones o similar	SI	SÍ	SÍ	SÍ
Vestirse las prendas de la parte inferior del cuerpo	SI	SÍ	SÍ	SÍ
Vestirse las prendas de la parte superior del cuerpo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Mantenimiento de la salud	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Solicitar asistencia terapéutica	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Evitar situaciones de riesgo dentro del domicilio	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Evitar situaciones de riesgo fuera del domicilio	NA	NA	SÍ	SÍ
Pedir ayuda ante una urgencia	NA	NA	SÍ	SÍ
Cambiar y mantener la posición del cuerpo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cambiar de tumbado a sentado en la cama	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Permanecer sentado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cambiar de sentado en una silla a estar de pie	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Permanecer de pie	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cambiar de estar de pie a sentado en una silla	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Cambiar el centro de gravedad del cuerpo mientras se está acostado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

Para todos los casos	Grupos de edad			
	3-6	7-10	11-17	18 y más
Desplazarse dentro del hogar	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos para vestirse	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos para comer	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos para lavarse	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos no vinculados al autocuidado	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos entre estancias no comunes	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Acceder a todas las estancias comunes del hogar	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Desplazarse fuera del hogar	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Acceder al exterior	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos alrededor del edificio	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos cercanos en entornos conocidos	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos cercanos en entornos desconocidos	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos lejanos en entornos conocidos	NA	NA	SÍ	SÍ
Realizar desplazamientos lejanos en entornos desconocidos	NA	NA	SÍ	SÍ
Realizar tareas domésticas	NA	NA	NA	SÍ
Preparar comidas	NA	NA	NA	SÍ
Hacer la compra	NA	NA	NA	SÍ
Limpiar y cuidar de la vivienda	NA	NA	NA	SÍ
Lavar y cuidar la ropa	NA	NA	NA	SÍ

Sólo en los casos de personas con una condición de salud que pueda afectar a las funciones mentales	Grupos de edad			
	3-6	7-10	11-17	18 y más
Tomar decisiones				SÍ
Decidir sobre la alimentación cotidiana	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Dirigir los hábitos de higiene personal	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Planificar los desplazamientos fuera del hogar	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Decidir sus relaciones interpersonales con personas conocidas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Decidir sus relaciones interpersonales con personas desconocidas	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Gestionar el dinero del presupuesto cotidiano	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Disponer su tiempo y sus actividades cotidianas	NA	SÍ	SÍ	SÍ
Resolver el uso de servicios a disposición del público	NA	NA	SÍ	SÍ

La determinación del grado y nivel oficial de dependencia se obtiene a partir de la puntuación final obtenida en el BVD de acuerdo con la siguiente escala:

- De 0 a 24 puntos, sin grado reconocido.
- De 25 a 39 puntos, Grado I nivel 1.
- De 40 a 49 puntos, Grado I nivel 2.
- De 50 a 64 puntos, Grado II nivel 1.
- De 65 a 74 puntos, Grado II nivel 2.
- De 75 a 89 puntos, Grado III nivel 1.
- De 90 a 100 puntos, Grado III nivel 2.

En función de los resultados obtenidos, emiten su resolución adecuando un Plan Individual de Atención (PIA). Determinarán las modalidades de intervención más

adecuadas a las necesidades del solicitante entre los servicios y prestaciones económicas previstas en la resolución para su grado y nivel.

Independientemente de que un nuevo usuario pueda tener reconocida o no legalmente su situación de dependencia, cuando llega a una institución residencial, siempre hay que aplicar un protocolo de valoración del grado de dependencia y, sobre todo, de las necesidades reales de apoyo que tiene para conocer y clasifica su nivel de asistencia y así poder proporcionarle los servicios y atenciones adecuados a sus características.

Para que la valoración de las distintas áreas sea lo más objetiva posible, cada centro determinará qué escalas o índices de valoración utilizará. Hay distintas escalas y cada una de ellas mide determinados aspectos y establece sus criterios de valoración. En apartado 2.3 de esta UF y en el apartado 1.2 del MF 3 haremos hincapié en ellas.

Estos cuestionarios son aplicados normalmente por el personal de enfermería o el terapeuta ocupacional al ingreso de la persona dependiente para determinar qué atención y asistencia precisa, así como para incluirle en los planes de cuidados del centro.

Normalmente estos instrumentos de valoración utilizados para determinar el grado de dependencia del residente se aplican preguntando al propio dependiente o a su familia y, después, se realizan modificaciones de puntuación obtenida en función de la observación de las capacidades real de la persona usuaria y de su evolución en el centro.

Una vez evaluado el grado de dependencia de la persona usuaria y su nivel de asistencia, se determinarán y seleccionarán los cuidados precisos que necesitará en función del tipo de dependencia, estado de salud y falta de autonomía que presente en cada una de las AVD, así como del objetivo que queramos lograr con nuestra intervención.

Los tipos de cuidados que se proporcionan en las instituciones de atención a personas dependientes pueden clasificarse en:

- cuidados preventivos
- cuidados asistenciales básicos o de mantenimiento
- cuidados sanitarios especiales
- cuidados psicosociales

A lo largo de la formación se irá explicando la índole de los diferentes cuidados

2.2.- Principios éticos de la intervención social con personas dependientes:

El cuidador guardará absoluto silencio sobre los procesos patológicos que sufran las personas usuarias y sobre cualquier asunto referente a su intimidad, actuando siempre bajo la responsabilidad y en coordinación con los profesionales de los cuales dependen directamente las directrices.

En el desempeño de su labor diaria el profesional deberá seguir unos principios deontológicos y desarrollarlos a través de actitudes éticas de comportamiento como el respeto, la confidencialidad y la discreción, entre otras.

Deontología profesional

El término deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos.

De esta manera el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España en su página Web, http://www.cgcom.es/deontologia, hace público su código deontológico y en la página http://www.terra.es/personal/duenas/codigo.htm podéis encontrar el de las enfermeras.

En el desempeño de la labor asistencial a la dependencia debemos acatar 3 tipos de normas

- NORMAS JURÍDICAS O LEYES: son las reglas de conducta de obligado cumplimiento que regulan y ordenan las actividades y actuaciones de todos los individuos que conviven en una sociedad determinada. En el ámbito de la institución de atención a personas dependientes, hay que cumplir con la normativa vigente que regula el sector. En el artículo 57 («Régimen disciplinario») del V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, se nombran las faltas leves, graves y muy graves por las que la empresa podrá sancionar al trabajador del sector de atención a la dependencia.
- NORMAS INSTITUCIONALES: se trata de las normas o reglas de conducta que regulan las actividades profesionales en la institución en la que se trabaja. Son normas propias del centro de trabajo y están reguladas por éste y supeditadas a las normas jurídicas, por lo que no pueden ser contravenidas.
- NORMAS MORALES: son aquellas normas, aceptadas libremente por los individuos, que regulan el comportamiento de los seres humanos en

sociedad. En el ámbito profesional de la atención a la dependencia, estas normas hacen referencia a la vocación y disciplina en el trabajo, así como a la protección de la persona usuaria frente a enfermedades y la colaboración para su rehabilitación. Así, el profesional sociosanitario llevará a cabo su trabajo de manera disciplinada y responsable, velará por la seguridad de las personas usuarias y formará parte activa del proceso de cuidados de los mismos.

Actitudes y valores.

Las personas usuarias del centro son nuestros clientes y a través del personal se ofrece una imagen de la institución, por lo que es muy importante una actitud correcta y cercana del profesional y un trato adecuado con la persona usuaria y su familia.

Se trata de *humanizar la relación* entre aquellas personas que intervienen en la atención y la persona usuaria. Es preciso por lo tanto, partir del reconocimiento de la dignidad de la persona usuaria, hay que verlo como el individuo concreto que es, en su globalidad, lo que implica acciones y actitudes que no se limiten a atender sus síntomas o dolencias concretas y que no lo distingan de los demás

Para adoptar esta visión, es necesario permitir la participación de la persona usuaria en las decisiones que le afecten, por lo que establecer una *comunicación* adecuada con éste será fundamental.

Por último, es preciso señalar que el acercamiento, la actitud y el trato con las personas atendidas en un centro sociosanitario deberá basarse en *las cualidades, capacidades y actitudes* profesionales a desarrollar durante el desempeño de la labor diaria del profesional en atención sociosanitaria a personas dependientes que se indican a continuación.

- Discreción y respeto hacia la persona usuaria y su entorno. El profesional en atención sociosanitaria deberá:
  - Guardar el secreto profesional sobre cualquier aspecto de lo que haya llegado a conocer durante su ejercicio profesional
  - Ponerse en el lugar de la persona usuaria, utilizando siempre la empatía (habilidad para estar consciente de reconocer, comprender y apreciar los sentimientos).
  - Asegurar la igualdad en la calidad de la prestación de su servicio, por encima de las diferencias y particularidades existentes entre las personas usuarias.
  - Respetar sus pertenencias.
- Trato adecuado a las personas usuarias. También, el profesional deberá:
  - Estar atento. Observar, escuchar e interesarse para detectar cambios en la situación de la persona usuaria.
  - Ser amable y comprensivo.

  - Mostrar buena voluntad de ayuda pero, diferenciando la verdadera necesidad de ayuda y fomentando la independencia supervisando a la persona usuaria en su terapia rehabilitadora.
  - Evitar relaciones de dependencia.
- Promoción de la autonomía de las personas preservando su independencia. Algunas actitudes que podrían ayudar a conseguirlo son:
  - Ofrecer opciones a la persona usuaria para que sea ella quién tome las decisiones
  - Respetar su independencia.
  - Fomentar la autonomía propia y respetar el derecho a la autodeterminación.
  - Respetar su individualidad y privacidad. Para ello, se llamará a las habitaciones antes de entrar y se les permitirá a los residentes momentos de soledad voluntaria, si así lo desean.
  - Respetar su inteligencia y experiencia
- Eficiencia y Responsabilidad. Estas actitudes se desarrollarán con una actitud comprometida y responsable.
- E. Comunicación y empatía. Facilitarán el éxito en estos aspectos las actitudes que lleven a:
  - Facilitar la comunicación.
  - Ser positivos.
  - Crear un ambiente de confianza que facilite el que expresen lo que les aflige, inquieta o preocupa, evitando que se aíslen.
  - Personalización de la atención. Dirigirse siempre a la persona con respeto, llamándola por su nombre y no tuteándole, no deben emplearse expresiones que denoten un trato infantil o paternalista como, por ejemplo, «los abuelotes». Ser flexibles, adaptándose a las necesidades y ritmos; conocer y tener en cuenta sus deseos.

Asimismo, los residentes tienen una serie de derechos que se deberán respetar en todo momento y que como profesional debemos acatar. Derechos de las personas usuarias de la institución de atención a la dependencia:

1. Derecho a la vida y a la igualdad plena ante la ley.
2. Derecho a la libertad de actuación y a la capacidad de elección.
3. Derecho a recibir un trato digno, con respecto hacia sus valores, creencias y preferencias,
4. Derecho a recibir las atenciones que precise en función de su grado de dependencia, y a que dichas atenciones sean proporcionadas por personal con formación adecuada para ello.
5. Derecho al honor, la intimidad personal y la privacidad.
6. Derecho a la información sobre sus derechos, su estado y diagnóstico.
7. Derecho a participar activamente y a la toma de decisiones.
8. Derecho a la tutela de los jueces y a la protección jurídica adecuada en caso de incapacitación legal,

Respeto por la confidencialidad e intimidad de las personas dependientes.

Una de las actitudes y valores más importantes en el trabajo de todos los profesionales que trabajan en la atención a personas dependientes, es el respeto por la confidencialidad protegida legalmente:

- En nuestro sistema legal, la protección de los datos de la salud deriva de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) dispone en su artículo 1: "La presente Ley tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar". Además, se refiere específicamente al tratamiento de los datos sanitarios tratándolos como datos que merecen especial protección, ya que se consideran de carácter personal junto con los que hacen referencia al origen racial y la vida sexual, por lo que sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, si así lo dispone una ley o el propio afectado lo consiente
- Además, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, señala en el artículo referido a Modificación de los niveles de seguridad (artículo 81, apartado 3) que, además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal referidos a los datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual; los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas; y aquéllos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.
- En el artículo 5.1. de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía de la persona usuaria y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, se indica que el titular del derecho a la información asistencial es la persona usuaria y que también podrán ser informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que la persona usuaria lo permita de manera expresa.
- Finalmente, señalar que siguiendo lo establecido en el apartado 6 del artículo 53 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cesión de los datos, incluidos los de carácter personal, necesarios para el sistema de información sanitaria, estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y a las condiciones acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, respecto a la confidencialidad, debemos saber que todos los profesionales que por el ejercicio de una determinada actividad estén sujetos al secreto profesional y toda persona que intervenga en el tratamiento de los datos de carácter personal, tienen la obligación de guardar el secreto profesional, no pudiendo revelar la información a terceros.

En los Centros de Día, de Noche y Residenciales se mantienen muchos datos de carácter personal de personas usuarias, trabajadores, proveedores, etc. Datos que la LOPD obliga a proteger de unas formas muy concretas. Específicamente:

- Estableciendo medidas de seguridad para proteger los ficheros que contengan datos de carácter personal, de Nivel Alto por la información relativa a la salud de las personas usuarias.
- Garantizando el ejercicio de los derechos que reconoce la ley a las personas físicas con datos de carácter personal en sus ficheros y especialmente a recabar el consentimiento de los afectados.

Delimitación del papel del profesional de atención sociosanitaria.

El profesional de atención sociosanitaria, al ser el experto que tiene un contacto más directo y una relación más frecuente con las personas usuarias, es una pieza fundamental del equipo interdisciplinar para conseguir el cambio y lograr los objetivos marcados en el plan individual de intervención de cada residente.

No obstante, la labor del el profesional en atención sociosanitaria esta supeditada a:

- El director del centro o persona que éste determine,
- Las actuaciones programadas por el equipo interdisciplinar
- Los protocolos de actuación establecidos por el centro y que detallan los procedimientos, tiempos y técnicas de realización de las diversas actuaciones.

Su labor asistencial fundamental es dando ayuda a las personas usuarias en el desempeño de las actividades de la vida diaria que no puedan realizar por sí mismos, efectuando tareas de atención personal y de su entorno.

A partir de estas aclaraciones previas, expondremos las delimitaciones de sus funciones y la importancia de cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales en el centro de trabajo para desarrollar correctamente su labor profesional.

Tareas frecuentes de los cuidadores son:

- Ayuda para el transporte fuera y dentro de la institución (por ejemplo, acompañarle al médico). Nunca dejar solos, ni permitirles su marcha errática,

disfuncional y descontrolada a las personas usuarias afectados de demencia o deterioro cognitivo severo.

- Ayuda para la higiene personal (peinarse, bañarse, etc.).
- Ayuda para la administración del dinero y los bienes.
- Supervisión en la toma de medicamentos.
- Colaboración en tareas de enfermería.
- Resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidado (por ejemplo, cuando se comporta de forma agitada).
- Ayuda para la comunicación con los demás cuando existen dificultades para expresarse.
- Hacer muchas "pequeñas cosas" (por ejemplo, llevarle un vaso de agua, acercar la radio, etc.).
- No dejar al alcance de las personas usuarias con un mayor grado de dependencia productos peligrosos (lejías, colonias, geles, etc.), instrumentos u objetos contundentes o cortantes y materiales peligrosos (cordones, plásticos, guantes, imanes, cinturones, etc.) que puedan ingerir o causar lesiones, pues esto supone un riesgo importante para su salud.
- Cuidará para que las personas usuarias no accedan a las salas comunes con la vestimenta incorrecta (por ejemplo, en pijama), procurará que permanezcan correctamente vestidos y calzados durante todo el día, así como en perfecto estado de higiene y aseo.
- Cuidará del nivel de ruidos (voces, gritos, etc.) y del uso racional de la televisión y la música. Un ambiente relajado facilita conductas más apacibles.

- Deberá estar en su área de trabajo excepto cuando, por razones organizativas, de atención urgente o actividad, sea precisa su permanencia en otro lugar. En este caso, la instrucción le será transmitida por el personal autorizado a tal efecto. Está totalmente prohibido el abandono del puesto de trabajo (salvo por razones urgentes) sin la autorización del responsable correspondiente.
- Con respecto a la delimitación del tiempo de descanso, el personal deberá utilizar este tiempo reglamentario de forma coordinada y en los turnos establecidos, a no ser que por necesidades del servicio no pueda hacerlo en esos momentos. Durante los cambios de turno y el descanso, se extremarán las medidas de atención, control y supervisión.
- Fomentará la colaboración y participación de las personas usuarias en los trabajos y actividades sencillas, siempre con total respecto a su autonomía personal y a la elección propia.

- Anotará toda conducta problemática, lesión, caída, etc., en el libro de incidencias
- Además realizará todas las labores siguiendo las pautas indicadas en los dos anteriores apartados

2.3.- Atención integral en la intervención.

La atención integral a la persona usuaria implica a todos los sectores que tengan relación con la misma: equipo multidisciplinar, familia, sociedad y el propio usuario.

Todas las acciones a realizar se plasman en Plan General de Intervención del Centro donde se recogen todas las acciones cuyo objetivo es el de proteger, promover, restaurar y mantener la salud y las redes sociales de relaciones de la persona usuaria.

El Proceso de Atención de las personas usuarias de centros de cuidados de media y larga duración consta de una serie de fases que conducen de forma paulatina al plan de intervención individual:

- VALORACIÓN: La observación, la entrevista, y la exploración física permiten la recogida de información de datos subjetivos (referidos por la persona usuaria), y objetivos (Aquellos que se pueden medir, observar, etc. Cuando hablamos de cuidados resulta útil usar modelos para ordenar la información, que estén vinculados al nivel de dependencia de ese persona usuaria para realizar las AVD. Podemos usar el modelo de Virginia Henderson de las 14 necesidades básicas. En esta fase el equipo interdisciplinar puede utilizar el cuestionario del RAI para aglutinar la información recogida por los diferentes profesionales.
- LISTA DE PROBLEMAS: Después de recoger los datos pertinentes procedemos a agruparlos en forma diagnóstica, utilizando la siguiente fórmula:

    - Problema: Etiqueta diagnóstica (Deterioro de la deglución, Incontinencia de urgencia, deterioro de la movilidad física, déficit de autocuidado: alimentación, etc.)
    - Etiología: Causa o raíz probable del problema.
    - Características definitorias: Signos y síntomas que apoyan la existencia de ese problema.

- PLANIFICACIÓN: En esta fase se establecen una serie de objetivos y se elabora el plan de cuidados. Debemos tener en cuenta que esta fase consta de tres subfases principales:

    - Priorización: Nos encontramos con una serie de problemas que seguramente no podremos tratar a la vez.
    - Objetivos: Podemos considerar a los objetivos como el elemento que hace mensurable el plan de cuidados.
    - Determinación de actividades: El equipo prescribe actividades encaminadas a tratar la causa de los problemas, y si esto no es posible se interviene sobre el propio problema.

- EJECUCIÓN DEL PLAN: Puesta en marcha de las actividades del plan de cuidados.

- EVALUACIÓN del plan de cuidados: El proceso de cuidar requiere un instrumento de retroalimentación que permita analizar el grado del cumplimiento de objetivos propuestos. En esta fase tendremos que analizar si "va bien el plan", si nos hemos equivocado en la valoración, en el diagnóstico, y en la planificación. Esta ésta etapa permite evaluar la eficacia y calidad del plan de cuidados.

Comunicación al equipo interdisciplinar de las necesidades de la persona usuaria.

El profesional de atención sociosanitaria es el experto que mantiene un contacto más directo y continuo con los individuos atendidos en la institución. En su quehacer diario deberá tener una actitud de observación de la conducta de la persona usuaria, de sus demandas y necesidades, así como de las posibles incidencias que puedan surgir.

Es fundamental que toda la información relevante sobre el residente sea transmitida de manera correcta y sistemática al equipo interdisciplinar para que éste pueda tomar medidas y poner en funcionamiento intervenciones para solventar las posibles necesidades o incidencias.

Esta transmisión de información puede hacerse verbalmente o por escrito. En el primero de los casos, el profesional comunicará a su inmediato superior aquellas incidencias detectadas en un momento puntual. Esta comunicación puede realizarse en las reuniones diarias que tienen lugar en los cambios de turno o si es algo urgente, dirigiéndose personalmente al profesional competente en la materia. En el segundo caso, por escrito, en el día a día el profesional de atención sociosanitaria utilizará una serie de documentos donde reflejará diferente información sobre la persona usuaria:

1. REGISTROS: son documentos donde se recoge información sobre las ABVD de la persona usuaria como por ejemplo, alimentación, actuaciones de higiene realizadas (aseo, ducha, cambios de absorbentes, etc.), cambios de ropa de cama, toma de medicación, dincontinencia urinariaresis, etc. Esta información se registra al finalizar el turno de trabajo y debe ser lo más exacta posible. Para ello cuenta con:
2. LIBROS DE INCIDENCIAS: cuando se detecte una anomalía o incidencia física, psicológica o en el comportamiento de un usuario, se reflejará en el libro de incidencias habilitado para ello. Este libro será leído posteriormente por los compañeros del turno siguiente y por el personal de enfermería, que también dejará escritas en este libro pautas y órdenes de trabajo. Las incidencias que es preciso reflejar en dicho libro son: incidencias sanitarias (si la persona presenta alteraciones en sus constantes vitales o cualquier otra incidencia), conductuales y psicológicas, así como incidencias en la alimentación, en la higiene y en el sueño.
3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS: en muchas instituciones de atención a personas dependientes se emplean programas informáticos de gestión en los que hay un apartado específico para el personal de atención directa. En

estos programas se reflejará toda la información relacionada con las personas usuarias para que el equipo interdisciplinar pueda acceder a ella y obrar en consecuencia.

ACTIVIDADES: UNIDAD

1. De las siguientes características de servicios para personas en situación de dependencia, ¿cuáles pueden ser comunes tanto a Centros Residenciales como a Centros de Día? Marca con una X en el cuadro que corresponda.

	Verdadero	Falso
Valoración Gerontológica Integral.		
Atención personal.		
Atención psico-social.		
Ofrece atención integral durante 24 horas.		
Elaboración de un Plan de Cuidados Individualizado.		
Actuaciones preventivas.		
Actuaciones de rehabilitación.		
Atención sociosanitaria integral para supervisión o asistencia continuada en la realización de AVD.		
Apoyo familiar.		
Prestación profesional: con planificación, supervisión y evaluación.		
La persona usuaria permanece en su entorno sociofamiliar habitual.		

2. Realiza un listado de los profesionales que podemos encontrarnos en la atención sociosanitaria.

3. Completa la siguiente frase con el nombre del profesional al que corresponden las funciones descritas.

   El profesional que prepara y administra los medicamentos prescritos en los tratamientos por los médicos, tomando las constantes de presión sanguínea, pulso y temperatura, y realizando el control de la higiene personal de las personas usuarias y de los alimentos y medicamentos que éstos puedan tener en sus habitaciones, es el _____

4. ¿Cuáles de las siguientes funciones NO corresponde realizar al profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes?

   a. Asiste y cuida a las personas usuarias en las actividades de la vida diaria que no puedan realizar por sí mismos.

b. Efectúa aquellos trabajos encaminados a la atención personal y del entorno de la persona usuaria.
c. Realiza tareas en las áreas asistencial, rehabilitadora, socializadora y educativa.
d. Para realizar sus tareas no está obligado a ajustarse a los protocolos de actuación establecidos en el centro concreto en el que trabaja.
e. Realiza trabajos programados por los diversos profesionales del equipo interdisciplinar.

5. Relaciona las funciones del profesional en atención sociosanitaria a personas dependientes con el tipo de actuación que le corresponda según la tabla que se expone abajo:

Tipo de actuación					
Movilización, traslado y deambulación	1	Limpieza y mantenimiento	5	Limpieza y mantenimiento	9
Atención sanitaria	2	Medicación	6	Primeros Auxilios	10
Apoyo Psicosocial	3	Actividades de la Vida Diaria	7	Higiene y aseo	11
Comunicación	4	Alimentación	8		

a. Higiene personal total y aseo de la piel.
b. Limpieza y mantenimiento de los utensilios de las personas usuarias.
c. Prevención de riesgos de lesiones, dolor, agitación e infecciones.
d. Apoyo en la deambulación.
e. Actuación ante atragantamiento.
f. Colaboración en la integración de usuarios y familiares.
g. Aviso a profesionales sanitarios.
h. Eliminación urinaria y fecal.
i. Tareas que complementen los servicios especializados de los profesionales de cada área.
j. Traslados, movilización y cambios posturales.
k. Recepción, distribución, presentación y recogida de alimentos.
l. Colaborar para facilitar la autonomía personal de las personas usuarias y su inserción en la vida social.
m. Acompañamiento en salidas de la persona usuaria del centro.
n. Administración, control y seguimiento de la farmacología prescrita.
o. Traslados a urgencias, especialista o cirugía hospitalaria.
p. Dar de comer y beber al usuario
q. Hacer las camas y colaborar en mantener ordenadas las habitaciones.
r. Trasladar al equipo interdisciplinar las incidencias (salud, interrelaciones sociales, tratamientos y necesidades).

6. Teniendo en cuenta las tareas en las que el profesional en atención sociosanitaria debe apoyar a otros profesionales en la fase de acogida del nuevo usuario a la llegada a la institución, indica cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos o falsos

a. El profesional en atención sociosanitaria debe realizar tareas como preparación de la habitación, recepción del residente, distribución de su ropa y objetos personales en la habitación y seguimiento de su adaptación.
b. Las tareas de limpieza, reparación y desinfección de la habitación, y las de revisión de instalaciones, disposición del mobiliario y acondicionamiento de la cama para la preparación de la habitación son responsabilidad exclusiva del profesional en atención sociosanitaria.
c. El día del ingreso, al nuevo usuario le es presentado el cuidador/auxiliar guía, que será el profesional de referencia básico desde los primeros momentos para atender sus necesidades, dudas, problemas y deseos.
d. La persona responsable de la gobernación y el cuidador designado, junto con los familiares y el nuevo usuario (si esto es posible), hacen la revisión y recepción de la ropa y objetos personales residente en la habitación asignada.
e. El auxiliar guía, continuando con la labor de ayuda a la integración del nuevo usuario, le presentará a éste los diferentes profesionales del centro.

7. Completa los siguientes párrafos escribiendo las palabras correctas.

“El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”, se denomina _____

El grado y _____ de la dependencia se valorará según un _____ que debe evaluar la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria y la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

La persona que necesita ayuda para las ABVD dos o tres veces a día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador ni tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal, tiene una situación de dependencia _____ o de _____

La persona que necesita ayuda para la realización de las ABVD, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal, tiene una situación de dependencia _____ o de _____

La persona que necesita ayuda para las ABVD varias veces al día y apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo

generalizado para su autonomía personal, tiene una situación de dependencia denominada _____ o dependencia de _____

El BVD (Baremo de Valoración de la Dependencia) permite identificar _____ niveles de cada grado de dependencia en función de la autonomía personal y de la intensidad del cuidado que requiere.

8. Según lo establecido en el Baremo de Valoración de los Grados y Niveles de Dependencia, ¿cuáles de las siguientes actividades SÍ se tendrán en cuenta para valorar la situación de dependencia en una persona?

   a. Comer y beber.
   b. Regulación de la micción y defecación.
   c. Lavarse.
   d. Otros cuidados corporales.
   e. Vestirse y desvestirse.
   f. Mantener la salud.
   g. Movimientos/transferencias corporales.
   h. Desplazarse dentro y fuera del hogar.
   i. Tareas domésticas.
   j. Tomar decisiones.
   k. Todas las anteriores.

9. Teniendo en cuenta el papel y los principios éticos en los que tiene que sustentarse la intervención del profesional en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, de los siguientes enunciados marca con una X los que sean verdaderos.

   a. Un código deontológico es un conjunto de criterios, normas y valores que los profesionales que ejercen una determinada actividad pactan, aprueban y cuyo cumplimiento asumen en el desarrollo de su actividad diaria para que las personas que solicitan sus servicios sean satisfechas por una buena ejecución.
   b. El profesional deberá ponerse en el lugar de la persona usuaria, utilizando siempre la empatía e intentando comprenderle y expresarle sentimientos de aprecio.
   c. El profesional en atención sociosanitaria deberá fomentar la autonomía propia y respetar el derecho a la autodeterminación de la persona usuaria.
   d. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (conocida como LOPD), establece que el acceso a los datos confidenciales de la persona usuaria debe limitarse a los profesionales que participan en su atención no teniendo obligación de denunciar los hechos que conozcan en el ejercicio de su profesión que puedan ser delictivos.

e. Un profesional que se dedique al cuidado de personas en situación de dependencia, especialmente si lo hace en un establecimiento especializado (centro sociosanitario), puede incurrir en su actividad en sólo dos tipos de responsabilidad: civil y administrativa.
f. El principal papel del profesional en atención sociosanitaria es el de la atención directa de las personas usuarias en las actividades de la vida diaria que no puedan realizar por sí mismos, efectuando tareas de atención personal y de su entorno.
g. Realizará sus funciones propias de manera responsable y eficaz, no aceptando responsabilidades o tareas que no sean de su competencia, ni delegando las que le son propias en otros profesionales que no estén debidamente capacitados.
h. Podrá llevar credencial o carné identificativo si lo desea, no teniendo obligación de usar el uniforme reglamentario del centro y los medios de protección facilitados.

10. Completa los siguientes enunciados escribiendo la palabra o frase que falta:

    El conjunto de acciones de carácter preventivo, curativo y de rehabilitación dirigidas a proteger, promover, restaurar y mantener la salud y las redes sociales de relaciones de la persona usuaria, prestadas por un equipo interdisciplinar compuesto por médicos, trabajadores sociales, animadores socioculturales, enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas y psicólogos, entre otros; y contempladas como servicios y prestaciones en el Plan General de Intervención del Centro, componen la _____

    Los procesos de valoración, diagnostico, pronóstico y tratamiento; así como la planificación, ejecución y evaluación de intervenciones son fases del desarrollo del _____

    La estrecha relación entre demandas y necesidades en la intervención en centros sociosanitarios con personas en situación de dependencia, hace imprescindible que los profesionales y personas que intervienen en su atención mantengan una comunicación ágil, basada en el manejo de un _____ comunes, actuando de forma _____; es decir, de forma conjunta y coordinada para enfocar el trabajo hacia el beneficio de la persona usuaria.

11. A.C.M de 78 años de edad ingresa en nuestra residencia

    Imaginemos a un persona usuaria que presenta los siguientes datos en la valoración:

    Oxigenación: Pide ayuda para expulsar secreciones, secreciones copiosas a través de traqueostomía.

Comer y beber normalmente: No tiene apetito desde hace dos semanas, El médico sugiere la presencia de una depresión. Ha perdido 4 Kg desde la última visita, 6 Kg por debajo de su peso.

Eliminar los residuos corporales: “No me da tiempo a llegar al servicio, estoy muy torpe y me lo hago en el camino”. Presenta hipotonía muscular en miembros inferiores, marcha dificultosa, precisa andador. Ha estado tres días con sonda y puede haber perdido tono en esfínteres urinarios.

Moverse y mantener una postura:

Evitar riesgos del entono y evitar lesionar a otros: La familia dice “ Se pasa el día caminando de un sitio a otro, tropieza y se cae con frecuencia. Desorientación T-E, alucinaciones, vagabundeo.

Elabora la lista de problemas y un plan de actuación individualizado